

1. Introducción y relevancia clínica

La **dermatitis herpetiforme (DH)** es una **enfermedad autoinmune crónica** caracterizada por **vesículas y pápulas intensamente pruriginosas**, distribuidas de manera **simétrica en superficies extensoras** (codos, rodillas, glúteos, espalda y cuero cabelludo).

Aunque su nombre sugiere una etiología viral, **no tiene relación con el virus del herpes**. Su base inmunológica está estrechamente vinculada a la **enfermedad celíaca (intolerancia al gluten)**, y ambas comparten mecanismos patogénicos mediados por anticuerpos IgA.

Relevancia clínica

- Es una **enfermedad rara**, pero **altamente sugestiva de enfermedad celíaca** subyacente, incluso si el paciente es asintomático a nivel intestinal.
- Su **reconocimiento permite el diagnóstico y manejo precoz del daño intestinal**, reduciendo riesgo de linfoma intestinal asociado a celiaquía.
- En EUNACOM, suele evaluarse el **vínculo entre la piel y la enfermedad celíaca**, y la respuesta terapéutica al **dapsona y dieta libre de gluten**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Relación con la enfermedad celíaca

- Más del **90% de los pacientes con dermatitis herpetiforme** presentan **enteropatía sensible al gluten**.
- Sin embargo, **solo un tercio** manifiesta síntomas digestivos.
- La exposición al gluten desencadena una **respuesta inmunológica cruzada**, donde los **anticuerpos IgA** dirigidos contra **transglutaminasa tisular intestinal (TG2)** reaccionan también con la **transglutaminasa epidérmica (TG3)**.

2.2. Mecanismo inmunopatológico

1. Ingesta de gluten (gliadina) → estimulación del sistema inmune intestinal → formación de anticuerpos IgA anti-TG2 y anti-TG3.
 2. Los anticuerpos IgA circulantes se depositan en la **lámina lúcida de la dermis papilar**, formando **microdepósitos granulares**.
 3. Activación del complemento → infiltración de **neutrófilos** → liberación de proteasas → daño y formación de **vesículas subepidérmicas**.
-

2.3. Factores genéticos

- Asociaciones con **HLA-DQ2 y HLA-DQ8**, similares a la enfermedad celíaca.
 - Predisposición familiar en 10–15%.
 - Frecuencia máxima entre los **20 y 50 años**, con ligera predominancia masculina.
-

2.4. Fármacos o desencadenantes asociados

- **Ingesta de gluten** (pan, trigo, cebada, centeno).
 - **Yodo y contrastes yodados** pueden exacerbar las lesiones.
 - **Estrés, infecciones y embarazo** pueden agravar el cuadro.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión elemental

- **Vesículas o pápulas eritematosas pequeñas**, agrupadas (“herpetiformes”), intensamente **pruriginosas**.
 - Suelen romperse por el rascado, dejando **erosiones y excoriaciones**.
 - Las ampollas intactas son raras debido al intenso prurito.
-

3.2. Distribución típica

- **Simétrica**, en áreas de extensión:
 - Codos y antebrazos.
 - Rodillas.
 - Nalgas.
 - Espalda alta y hombros.
 - Cuero cabelludo.
 - **Cara y mucosas**: poco frecuentes (a diferencia del pénfigo vulgar).
 - Las lesiones **aparecen en brotes** y **recidivan** si no se controla el gluten.
-

3.3. Síntomas asociados

- **Prurito intenso y ardor previo a la erupción.**
 - Lesiones nuevas aparecen en el sitio del prurito.
 - En muchos casos, hay **síntomas gastrointestinales leves o ausentes**, aunque puede existir **malabsorción subclínica**.
-

3.4. Evolución

- Curso **crónico y recurrente**.
 - La erupción cutánea **responde rápidamente a dapsona (48–72 h)**, pero **recurre al suspenderla**.
 - La **dieta libre de gluten** puede inducir remisión sostenida en meses a años.
-

3.5. Diagnóstico diferencial

Enfermedad	Características distintivas
Escabiosis	Prurito nocturno, surcos interdigitales, contactos afectados
Eccema dishidrótico	Vesículas en manos/pies, no simétrico
Dermatitis atópica o por contacto	Lesiones mal definidas, sin patrón simétrico ni depósitos de IgA
Pénfigo o penfigoide	Ampollas grandes, Nikolsky positivo o negativo, sin relación con gluten
Prurigo nodular	Pápulas liquenificadas por rascado crónico

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

- Brotes pruriginosos, vesiculares, simétricos, en superficies extensoras.
- Respuesta espectacular a la dapsona.
- Sospechar en adultos jóvenes o de mediana edad con antecedentes familiares o serología celíaca positiva.

4.2. Diagnóstico histológico e inmunológico

Examen	Hallazgo característico
--------	-------------------------

Biopsia de piel (lesión fresca)	Vesícula subepidérmica con microabscesos neutrofílicos en las papilas dérmicas
Inmunofluorescencia directa (IFD)	Depósitos granulares de IgA en la punta de las papilas dérmicas (patognomónico)
Serología	Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (TG2), anti-endomisio e IgA total
Biopsia intestinal (duodenal)	Atrofia vellosa en el 75% de los casos (confirmación de enteropatía)

Nota: Si la IFD es negativa, puede deberse a uso reciente de corticoides o dapsona.

4.3. Criterios diagnósticos (British Association of Dermatologists, 2024)

1. Prurito o quemazón con vesículas o pápulas agrupadas en áreas extensoras.
2. IFD positiva con depósitos granulares de IgA en papilas dérmicas.
3. Serología celíaca positiva (anti-TG2 o anti-endomisio).
4. Respuesta clínica rápida a dapsona o dieta libre de gluten.

Diagnóstico confirmado: presencia de los criterios 1 + 2, con apoyo de 3 o 4.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

- Control dual: **farmacológico (dapsona)** y **nutricional (dieta libre de gluten)**.
- La dapsona controla el prurito y las lesiones; la dieta trata la enfermedad subyacente.
- Evitar yodo, AINEs y alimentos con gluten (trigo, cebada, centeno, avena contaminada).

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Dapsona (fármaco de elección)

- **Dosis inicial:** 25–50 mg/día, aumentando gradualmente hasta 100–200 mg/día según respuesta.
- **Respuesta clínica:** prurito y lesiones mejoran en 1–3 días.
- **Mantenimiento:** dosis mínima eficaz (50–100 mg/día).
- **Monitorización:** hemograma y G6PD antes y durante tratamiento (riesgo de anemia hemolítica y metahemoglobinemia).

Efectos adversos:

- Anemia hemolítica (más frecuente en déficit de G6PD).
- Metahemoglobinemia.
- Neutropenia o agranulocitosis.
- Náuseas, cefalea, neuropatía periférica.

B. Sulfonas alternativas o inmunomoduladores

- **Sulfasalazina o sulfapiridina:** alternativas en intolerancia a dapsona.
- **Colchicina, nicotinamida o tetraciclinas:** casos leves.
- **Corticoides tópicos:** alivio sintomático localizado.
- **Corticoides sistémicos:** raramente necesarios (brotes extensos o refractarios).

5.3. Dieta libre de gluten (base del tratamiento a largo plazo)

- Elimina **trigo, cebada, centeno y avena contaminada**.
- La dieta estricta permite:

- Disminuir la dependencia de dapsona.
- Normalizar serología celíaca.
- Recuperar mucosa intestinal.
- Prevenir linfoma intestinal asociado.

MINSAL Chile (2023): recomienda acompañamiento por nutricionista entrenado en enfermedad celíaca y seguimiento anual con serología y ferritina.

5.4. Manejo complementario

- Suplementar hierro, ácido fólico, vitamina B12 y D en casos con malabsorción.
 - Evitar medicamentos que contengan gluten o yodo.
 - Educación alimentaria para paciente y familia.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa / Consecuencia	Prevención
Anemia hemolítica	Dapsona (efecto adverso)	Control hematológico
Metahemoglobinemia	Dapsona	Ajustar dosis / usar antioxidantes
Linfoma intestinal asociado a enteropatía	Exposición prolongada al gluten	Dieta libre de gluten
Deficiencia nutricional (hierro, folato, B12)	Malabsorción	Suplementación

**Infección secundaria por
excoriaciones**

Rascado intenso

Higiene y tratamiento
tópico

Pronóstico:

- Con tratamiento adecuado, es **excelente**.
 - La **dapsona** controla los síntomas rápidamente, y la **dieta libre de gluten** puede inducir **remisión completa** en 1–2 años.
 - Sin control dietario, la enfermedad persiste y puede aumentar el riesgo de **linfoma intestinal o adenocarcinoma del intestino delgado**.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Vesículas agrupadas (“herpetiformes”) + prurito intenso + IgA granular → Dermatitis herpetiforme.**
 2. **Relación directa con enfermedad celíaca**, aunque sin síntomas digestivos.
 3. **Dapsona mejora las lesiones en 48–72 horas.**
 4. **La dieta libre de gluten es esencial para la remisión completa y prevención del linfoma.**
 5. Lesiones predominan en **superficies extensoras (codos, rodillas, glúteos)**.
 6. En EUNACOM, el distractor frecuente es **penfigoide ampollar**, pero este se diferencia por **ampollas tensas y Nikolsky negativo**.
-



Errores comunes

- Tratar solo con dapsona y **no indicar dieta libre de gluten** (la enfermedad reaparece al suspenderla).
 - No investigar enfermedad celíaca (serología o biopsia intestinal).
 - No medir G6PD antes de iniciar dapsona (riesgo de hemólisis).
 - Confundir con escabiosis u otras dermatitis pruriginosas.
 - Continuar consumo de avena contaminada o gluten oculto en alimentos industrializados.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **dermatitis herpetiforme** es una **dermatosis autoinmune asociada a enfermedad celíaca**, mediada por **anticuerpos IgA anti-transglutaminasa epidérmica**.
2. Cursa con **vesículas y pápulas agrupadas, muy pruriginosas**, en **zonas extensoras**.
3. El **diagnóstico** se confirma por **depósitos granulares de IgA en papilas dérmicas (IFD)** y **serología celíaca positiva**.
4. El **tratamiento de elección** es **dapsona + dieta libre de gluten estricta**.
5. La **dapsona controla el prurito rápidamente**, pero **la dieta** es la única medida curativa.
6. Sin tratamiento, puede desarrollarse **linfoma intestinal asociado a celiaquía**.
7. En EUNACOM, el punto clave es el **vínculo piel–intestino** y la **respuesta dramática a dapsona**.